KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
KLINIKA ZA OČNE BOLESTI
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
10000 Zagreb, Kišpatićeva 12, tel +385 (1) 2376 426
Predstojnik: Prof. dr. sc. NENAD VUKOJEVIĆ, dr.med

SPECIJALISTIČKA AMBULANTA OČNE KLINIKE
tel. +385 (0)1 2376 426 (svakim radnim danom od 13 do 14,30 sati),
fax: +385 (0)1 2421 806,
e-mail: predbiljezbe.poliklinika.oci@kbc-zagreb.hr

Nalaz

Protokol broj: 2026101944621

PODUNAVAC PETRA
Rođena: 08.06.1979.
Adresa: J.J.STROSSMAYERA 156, 31000 OSIJEK
Dijagnoza: D33.3 – Dobroćudna novotvorina kranijalnih živaca
MBO: 102066421
Datum nalaza: 04.11.2026.

Anamneza: Pacijentica u dobi od 47 godina upućuje se radi subspecijalističke obrade jednostrane retrobulbarne i temporalne nelagode u području lijevog oka koja traje unazad pet mjeseci. Simptome opisuje kao kontinuirani osjećaj unutarnje kompresije i pritiska usmjerenog prema uški, bez dnevnih oscilacija. Prethodno provedena lokalna nadomjesna terapija umjetnim suzama bez konzervansa koja nije dovela do ublažavanja simptoma. Nosi refrakcijsku korekciju za rad na blizinu i srednjoj udaljenosti.

Heteroanamnestička anamneza: Tonsillectomia bilateralis (2012., KBC Merkur, LA); endonazalna sinusokirurgija radi ekstirpacije benignih tvorbi paranazalnih sinusa (2023., OBŽ Vinkovci, LA).
Od 1991. godine boluje od psorijaze, koja je u stabilnoj stacionarnoj fazi, trenutno bez sistemske imunomodulacijske i biološke terapije.
Negira kraniofacijalne i očne traume, teže kardiovaskularne ili metaboličke bolesti te poznate alergije na lijekove.
Negira glavobolje, vrtoglavicu, dvoslike, ispade vidnog polja i neurološke ispade. Ne konzumira alkohol, puši iqos.
Terapija: Nihil

U prilogu LAB nalaz, RTG s/p, CT mozga i orbita.

Oštrina vida i refrakcija :

VOD : 1.0 (uz korekciju +1.75 Dsph / -0.50 Dcyl os 90°)

VOS : 1.0 (uz korekciju +1.75 Dsph / -0.75 Dcyl os 85°)

Očni tlak :

TOD : 15 mmHg

TOS : 16 mmHg

Biomikroskopija prednjeg segmenta:

(OD): Vjeđe anatomski pravilnog položaja. Spojnica mirna, bjeloočnica sedefasta, bez episkleralne injekcije. Rožnica prozirna, sjajna, epitel intaktan. Prednja sobica optički čista, bistra, primjerene dubine, bez prisutnosti stanica i proteina. Šarenica pravilnog crteža. Zjenica okrugla, centralna, očuvanih izravnih i konsenzualnih fotomotoričkih reakcija. Leća prozirna.

(OS): Vjeđe pravilnog položaja, bez spuštenosti . Spojnica mirna, bez znakova zastoja u episkleralnom spletu i edema. Rožnica prozirna, intaktna. Prednja sobica bistra, bez fibrinske reakcije. Šarenica uredne strome. Zjenica okrugla, jednakog promjera kao desna, promptne fotomotorike. Relativni aferentni zjenični defekt (je negativan. Leća prozirna.

Exophthalmometria :

Okulomotorna pokretljivost potpunog je opsega obostrano, bez ograničenja bulbomotorike i dvoslika u svih devet položaja pogleda. Test pokrivanja i otkrivanja pokazuje ortoforiju. Egzoftalmometrija po Hertelu (baza 98 mm): OD 16 mm / OS 16 mm – bez klinički manifestne protruzije očne jabučice.

Oftalmoskopija očnog dna u farmakološkom proširenju zjenica :

> **(OD):** Papila vidnog živca oštro ograničena, ružičasta, u razini mrežnice (omjer ekskavacije 0.3). Žuta pjega očuvanog foveolarnog refleksa. Vaskularno stablo i periferna mrežnica urednog statusa.
>
> **(OS):** Papila vidnog živca jasnih i oštrih granica, normoemična, fiziološke ekskavacije. Unatoč prisutnom retrobulbarnom ekspanzivnom procesu, **trenutno nema manifestnih znakova aksoplazmatskog zastoja (bez edema papile), nema optokofacijalnih venskih anastomoza te nema znakova atrofije vidnog živca**. Makula urednog profila i refleksa. Vaskularno stablo bez znakova staze u središnjoj mrežničnoj veni ili arterijske kompromitacije. Periferna mrežnica prislonjena u potpunosti.
>
> ***Klinički:*** Očuvana oštrina vida i strukturno uredno očno dno odgovaraju početnoj, neurooftalmološki kompenziranoj fazi ekstraaksijalnog meningeoma, koji vrši kompresiju na duralne ovojnice bez ireverzibilne kompromitacije aksonalnog prijenosa ili mrežnične cirkulacije.

<u>Pacijentica se uputi na MSCT angiografiju.</u>

Nalaz : MSCT angiografija (CTA) intrakranijskih krvnih žila i orbita

H 57.1 Retrobulbalna kompresivna bol lijevog oka ? Susp. meningeom?

Pacijentica upućena na pregled u sklopu daljnje evaluacije prethodno verificiranog vretenastog zadebljanja optičkog kompleksa lijevo

MSCT ANGIOGRAFIJA KRVNIH ŽILA I ORBITA: Na danas učinjenom pregledu učinjeni su presjeci u ranoj arterijskoj fazi uz dopunske MPR i 3D VRT rekonstrukcije ciljano za područje orbita i optičkog kanala.

Na učinjenim presjecima i rekonstrukcijama intrakranijskog vaskularnog sustava, prikaže se simetričan izgled vertebralnih arterija. Normalno oblikovana a. basilaris. Uredan prikaz i izgled arterija stražnje cirkulacije. Uredna širina i tijek obje ACI u ekstra i intrakranijskom dijelu. Nema aneurizmatskih proširenja, AVM ili AVF. Nema hemodinamskih suženja intrakranijalno.

Ciljanom analizom vaskularnog i perineuralnog prikaza u području lijeve orbite, u intrakonalnom prostoru jasno se diferencira patološko, izrazito intenzivno i homogeno nakupljanje kontrastnog sredstva strogo lokalizirano unutar duralnih i arahnoidalnih ovojnica vidnog živca.

Na aksijalnim CTA rekonstrukcijama jasno se vizualizira patognomoničan znak dvostruke pruge, a na koronarnim rekonstrukcijama prstenasto nakupljanje kontrasta uz jasno pošteđen središnji, neobojeni aksijalni snop samog vidnog živca. Oftalmična arterija lijevo prikazuje se u cijelosti uredno ispunjena kontrastom, potisnuta je medijalno uslijed zadebljanja ovojnica, bez znakova okluzije i aneurizmatskih proširenja. Kontralateralna orbita u vaskularnom i neuralnom prikazu je urednih karakteristika.

ZAKLJUČAK: Ciljanom CTA analizom rane arterijske faze jasno se diferencira tumorska infiltracija duralnih ovojnica lijevog vidnog živca uz poštedu samog aksonalnog snopa. Nalaz u potpunosti potvrđuje ekstraaksijalni tumor – meningeom ovojnice lijevog vidnog živca. Vaskularna anatomija i prohodnost oftalmične arterije lijevo su očuvani. Preporučuje se hitna obrada radi razmatranja operativnog liječenja.

Tibor Kormendy, dr.med, specijalist radiologije i subspecijalist dijagnostičke neuroradiologije

Kliničko mišljenje:

Verificirani meningeom ovojnice lijevog vidnog živca uzročni je supstrat perzistirajućih retrobulbarnih i temporalnih kompresivnih smetnji. S obzirom na mikrolokalizaciju lezije te anatomsko-topografske odnose prema vidnom živcu, **liječenje radioterapijom nije tehnički izvedivo niti indicirano**, čime je primarni terapijski izbor orbitalna operativna dekompresija s resekcijom.

Kako u ovoj ustanovi ne postoje tehnički i subspecijalistički uvjeti za izvođenje ovako kompleksnog operativnog zahvata, indicira se hitno upućivanje bolesnika u ustanovu najviše razine. – Konzultirana doc. dr. sc. Jelena Juri Mandić, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost okuloplastična kirurgija.

Preporuke:

Preporučuje se u najkraćem roku učiniti (MR) mozga i orbita s kontrastnim sredstvom (uz ciljane protokole za vidni živac i supresiju masti) radi precizne procjene eventualnog širenja tumora prema optičkom kanalu i supraselarnoj cisterni, a kao priprema za operativni zahvat.

Pacijenticu će se **izravno kontaktirati radi organizacije i provođenja daljnje obrade te operativnog zahvata u ustanovi više razine**.

Terapija : Nastaviti primjenu optičke korekcije te umjetnih suza bez konzervansa prema potrebi. U slučaju pojave naglog pada oštrine vida, ispada u vidnom polju, asimetrije zjenica ili dvoslika, potrebno je hitno javljanje u dežurnu oftalmološku službu.

prof. dr. sc. Nenad Vukojević, dr.med.

spec. oftalmolog i subspecijalist za neurooftalmologiju i orbitu

(0113751)

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – REBRO
KLINIKA ZA OČNE BOLESTI

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan.